SDD 256 Sujet n°1

Spécialité : Thérapeutique

Date : 20/08/2023
Auteur : ELAYLI Robin (DES Psychiatrie Grenoble, ECN 2023)
Relecteur(s) : VILLARD Sébastien (DES Médecine interne Paris, ECN 2023) ; TRIN Kilian (Interne de Santé publique, RS Pharmacologie)

Domaine d'apprentissage principal	Stratégie de prise en charge
Domaine d'apprentissage secondaire	Interrogatoire
Item(s) en lien avec la station	ITEM 110 trouble du sommeil ITEM 74 Prescription de psychotrope
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 135 trouble du sommeil SDD 256 Prescription d'hypnotique / anxiolytique
Matériel nécessaire à la station	- 1 Modèle d'ordonnance classique TACFA - 1 Modèle d'ordonnance sécurisé TACFA - 1 crayon - 1 feuille blanche - 1 bureau - 2 chaîses
Contexte de la station	

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes le médecin généraliste de Mme Enries, 58ans, qui vous consulte dans votre cabinet pour une insomnie d'apparition récente depuis l'AVC de son mari il y a 3 semaines. Elle souhaiterait trouver un moyen afin de mieux dormir.

Consignes :
Vous devez réaliser en 7 minutes /annoncer/prescrire :
- Réaliser l'entretien autour de la plainte de votre patiente afin d'orienter votre prise en charge.
- Rechercher les informations indispensables à la mise en place de la prise en charge souhaitée
- Mettre en œuvre la prise en charge nécessaire en informant la patiente sur celle-ci et en réalisant les ordonnances nécessaires.

Vous ne devez pas :
- Réaliser un examen clinique
- Faire une psychothérapie lors de l'entretien avec cette patiente
- Préparer le retour à domicile de son mari

Attention : Vous avez 7 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (max 15 items)			
Rubrique 1 : Caractéristique du trouble du sommeil			
1.	- Questionne les troubles du sommeil (+ 0,5 point par élément) : ● Insomnie d'endormissement ● Réveils nocturnes avec difficultés de ré-endormissement ● Réveil précoce ● Signes évocateurs d'un SAOS (recherche au moins 3 sur 4) : Ronflements, Pauses respiratoires, Céphalées matinales, Nycturie ● Retentissement diurne (Recherche au moins 2 sur 5) : Somnolence, Fatigue, Trouble d'attention, trouble de concentration, trouble de mémoire	2,5	☐
2.	- Recherche une comorbidité psychiatrique (anxiété, dépression)	1	☐
3.	- Questionne sur les habitudes de sommeil de la patiente (recherche au moins 2 des 3 éléments suivants) : ● Heure moyenne du coucher et du lever jours de travail et de repos ● Durée moyenne de sommeil lors des jours de travail ET de repos ● Présence d'activité éveillante dans la soirée (donnez le point si recherche au moins 1 éléments parmi : ○ Pratique de sport, prise d'excitant (café, tabac, thé), ○ Exposition au écran)	1	☐
Rubrique 2 : Entretien pré-thérapeutique			
4.	- Demande si la patiente prend des traitements ET recherche une automédication (demande si utilise des moyens non médicamenteux ET médicamenteux face à ces troubles d'endormissement)	1	☐
5.	- Recherche les 5 contre-indications aux benzodiazépines : ● Syndrome d'apnée du sommeil ● Insuffisance hépatique grave ● Myasthénie ● Insuffisance respiratoire grave ● Antécédent d'hypersensibilité à la substance active	1	☐
6.	- Rechercher un risque de trouble de l'usage chez la patiente	1	☐
Rubrique 3 : Education thérapeutique			
7.	- Explique les risques liés à ce médicament (1 pt par élément) : ● Risque de pharmacodépendance du médicament prévu ● Risque pour la conduite automobile après la prise de ce médicament	2	☐

8.	- Ré-explique les règles de bonnes hygiènes du sommeil (au moins 2 sur 4) : ● Se réveiller à heure fixe le matin ● S'exposer à la lumière la journée en particulier le matin ● Ne pas rester éveillé dans le lit ● Pas de sport, de café, de tabac, ou d'écran avant d'aller dormir	1	☐
9.	- Proposer en plus une approche non médicamenteuse de type psychothérapeutique	0,5	☐
	Rubrique 4 : Prescription		
10.	- Met sur l'ordonnance tous les éléments suivants : Identité du prescripteur, identité du patient, nombre de médicament prescrit en bas dans le petit encadré, date, signature du médecin	1	☐
11.	- Prescription d'un hypnotique	1	☐
12.	- Prescription du zopiclone	1	☐
13.	- Prescription sur le bon type d'ordonnance : > Ordonnance classique pour zopiclone. > Si prescrit zolpidem, le fait sur une ordonnance sécurisée, avec les chiffres écrits en lettre > Si prescrit un anxiolytique, sur ordonnance classique	1	☐
14.	- Prescription sur une durée inférieure à la durée réglementaire : ● Moins de 4 semaines si prescrit bien un hypnotique ● Moins de 12 semaine si prescrit un anxiolytique	1	☐
15.	- Écrit sur l'ordonnance les consignes de prise du médicament ET les explique à la patiente (au moins 2 des 3 éléments suivants, précisé à l'oral ET à l'écrit, dont au moins le premier) : ● Nombre de prise par jour ● Si prescrit un hypnotique : moment de prise avant le coucher ● Si prescrit anxiolytique : moment de prise lors d'épisode anxieux aiguë OU Si besoin	1	☐
	Communications et attitudes (ICI) (max 5 grilles)		
	1. APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair	1 pt	☐

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

	2. APTITUDE À QUESTIONNER	1 pt	☐

Performance Insuffisante	Performance Limite	Performance Satisfaisante	Performance Très Satisfaisante	Performance Remarquable
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise de différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant le plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

	3. APTITUDE À FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS AU PATIENT / AUX AIDANTS	1 pt	☐

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Renseigne le patient / aidant de manière inadaptée (ex. informations inexactes) ou ne fait aucun effort pour renseigner le patient/aidant	Donne des renseignements de façon incomplète ou s'attarde à des renseignements éloignés du problème	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille quelque peu à ce que le patient /aidant comprenne	Donne des renseignements de façon adaptée. Veille à ce que le patient / aidant comprenne	Renseigne avec justesse et illustre ses explications pour qu'elles soient bien comprises

	11. APTITUDE À PLANIFIER LES SOINS (= approche centrée sur le patient)	1 pt	☐

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Le projet des soins ne correspond pas au tableau clinique ou ne prend pas en compte le patient et ses besoins	Le projet des soins est adapté au tableau clinique Omet quelque fois de prendre en compte les capacités / contraintes du patient	Fait participer le patient à la planification de ses soins *(ex invite le patient à poser des questions)*	Favorise la prise de décision en partenariat avec le patient.	Favorise la prise de décision en partenariat avec le patient. Renforce la confiance du patient et son autonomie

	12. APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE (situations aiguës / chroniques)	1 pt	☐

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Est incapable de proposer une prise charge adaptée à la situation clinique	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels, n'arrive pas à justifier la démarche	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels et justifie la démarche.	Propose une prise pertinente. Ne s'attarde pas au traitement/prise en charge inutile et justifie la démarche.	Etablit l'ordre de priorité des différents aspects de la prise en charge du patient (hiérarchise).

	TOTAL	**… / 22 points**	

ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

L'étudiant.e reçoit Mme Enries, 58ans, car n'arrive plus à dormir correctement depuis l' AVC de son mari. Hospitalisation de son mari il y a 3 semaines en réanimation, puis en service de neuro-vasculaire dans les suites d'un AVC ischémique. Son mari est toujours hospitalisé. Elle présente des insomnies aiguës et souhaiterait se faire prescrire quelque chose pour dormir

Plan de la station ECOS :

2 chaises, un bureau. Acteur.trice et candidat.e assis de part et d'autre du bureau

<u>Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :</u>

"Je viens vous voir car depuis 3 semaines, suite à l'hospitalisation de mon mari pour un AVC, je n'arrive plus a dormir correctement, je suis très fatiguée et j'aimerais avoir quelque chose qui m'aide à dormir"

Identité du patient :

Nom : Enries
Prénom : Jeanne
Tranche d'âge : 58 ans
Poids 62 kg
Taille 164 cm

Mode de vie :

- Situation de famille : Marié(e)
- Nombre enfant(s) : 1
- Petit(s) enfant(s) : 0
- Profession : Comptable
- Loisir(s) : Gymnastique, Voyage
- Lieu de vie : Maison plain-pied
- Dépendance(s) et addiction(s) : aucune
- Allergie(s) connue : Non

Comportement global :

- Fatigué, triste
- À l'écoute, souhaite avoir un traitement pour aider à dormir

Antécédents personnels :

- Une grossesse ayant donné un accouchement par voie basse d'un enfant
- Insuffisance veineuse chronique

Antécédents familiaux :

- Hypertension artérielle chez son père

Médicaments :

Aucun traitement

Symptômes positifs :

- Description des symptômes :
    - Insomnie avec difficulté d'endormissement depuis l'AVC de son mari
    - Lors du coucher, humeur triste, pensée triste
    - Humeur triste persistante
    - Fatigue la journée car se lève quand même plus tôt
    - Pas de somnolence diurne excessive
    - Pas de ronflements de pauses respiratoires de céphalées matinales de nycturie
    - Pas de traitement
- Si demande de spécifier l'insomnie : "J'ai beaucoup de mal à m'endormir la nuit. Je reste facilement éveillé jusqu'à 3 - 4h du matin"

- Si demande ce que vous faites lorsque cela arrive : “Je reste dans mon lit souvent, ou je me réveille pour marcher un peu”
- Si demande comment vous allez vous coucher : “je vais me coucher vers 23h et je reste dans mon lit couché”
- Si vous demande votre durée moyenne de sommeil : “Environ 3 - 4h”
- Si vous demande votre heure de réveil : “Je me réveil souvent vers 8h même si je suis fatiguée”
- Si vous demande si vous ronflez ou faites des pauses respiratoire : “ Pas à ma connaissance et mon mari ne m’en a jamais parlé”
- Si demande si vous avez déjà entendu parler de la myasthénie dans votre parcours de soins (c’est une des contre-indications à chercher) : “non pas du tout”
- Si vous demande si vous avez une insuffisance hépatique, une insuffisance respiratoire, un syndrome d’apnée du sommeil ou une allergie médicamenteuse : “Non pas du tout”
- Si vous demande si vous avez des antécédents addictifs/de trouble de l’usage de substance : Non je n’ai jamais été addict à quelque chose
- Si pose des questions sur votre humeur : “eh bien je suis triste, je pense que ça se comprend vu le contexte, mais particulièrement au coucher. Ça fait maintenant 25 ans que je suis mariée, et je n’ai pas l’habitude de dormir sans lui. Le savoir à l’hôpital cela m’inquiète et j’ai peur pour lui”
- Si demande par rapport à l’anxiété : “je me sens très inquiète au vu de la situation, mais ce ne sont pas ces inquiétudes qui me maintiennent éveillé. C’est vraiment la tristesse”
- S’il vous propose de voir une/un psychiatre : “oui si vous pensez que cela peut m’aider, mais je voudrais surtout pouvoir bien dormir au plus vite plutôt que parler de ma situation.”

Questions de relance :

- Si l’étudiant ne vous a toujours pas prescrit quelque chose après 5min : dire “mais du coup vous n’allez rien me donner pour m’aider à dormir ?”
- Si l’étudiant ne précise pas comment vous devez prendre le médicament, dire “et donc je le prends comme ça pendant le repas du soir ? “ (Il doit vous dire que non, il faut le prendre 10 min avant d’aller se coucher)
- Si l’étudiant commence à vous expliquer qu’il va vous donner quelque chose pour l’anxiété, dire “ah mais docteur ce n’est vraiment pas l’anxiété qui m’empêche de dormir”
- Si l’étudiant ne vous précise pas pendant combien de temps il vous prescrit le médicament, dire “et donc je le prends pendant combien de temps ? et tous les jours ? ”

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

Matériel nécessaire à la station :

- 1 Modèle d'ordonnance classique TACFA
- 1 Modèle d'ordonnance sécurisé TACFA
- 1 crayon
- 1 feuille blanche
- 1 bureau
- 2 chaîses

Positionnez les deux types d'ordonnances sur la table côte-à-côte. Mettez un stylo accessible fonctionnel à côté, ainsi qu'une feuille blanche a disponibilité.